

Roteiro do Supervisor

A primeira conversa: explicar o que a Aliviar é, responder o que a pessoa vai perguntar, dizer o preço na hora certa e combinar o começo.

Para quem fala com a pessoa antes de a Curadoria existir — e continua com ela depois: o Supervisor do processo (ADR-100). Complementa o Guia do Supervisor, que trata do sistema; este trata da conversa.

ANTES DE QUALQUER FRASE: O QUE VOCÊ ESTÁ VENDENDO

Você não vende um médico. Você vende **o fim da procura às cegas**.

A pessoa que te liga já tentou: perguntou a conhecidos, leu na internet, ouviu três opiniões diferentes e não sabe em qual confiar. O que a Aliviar oferece é alguém que estuda o caso dela e volta com **três caminhos explicados** — e a razão de cada um estar ali.

Isso se explica em uma frase e se sustenta sozinho. **Não precisa de entusiasmo**: quem está com medo desconfia de vendedor animado.

1 · A abertura — os primeiros trinta segundos

A pessoa preencheu o formulário e está esperando. Ela não sabe quem você é nem o que vai ouvir. Comece dizendo *quem é você* e *por que ligou*, e devolva a palavra rápido.

DIGA ASSIM

"Oi, [nome]? Aqui é [seu nome], da Aliviar. Você deixou um contato no nosso site pedindo ajuda para encontrar um médico. **Consegue falar agora?**"

Se sim: "Antes de eu explicar como a gente trabalha, **me conta o que está acontecendo.**"

PERGUNTE ANTES DE EXPLICAR — SEMPRE NESSA ORDEM

A tentativa é abrir com o discurso pronto sobre a Aliviar. **Não faça isso**. Quem explica antes de perguntar está falando com uma pessoa genérica, e a pessoa percebe.

Deixe ela contar primeiro. Além de ser mais humano, é o que permite você explicar a Aliviar *com o caso dela dentro* — e aí a explicação convence sozinha.

2 · Escutar — e é aqui que a conversa se decide

Deixe falar. Não interrompa para explicar o serviço. Enquanto ela fala, você está atrás de quatro coisas:

O que ouvir	Para quê
O que ela já tentou	É o tamanho do cansaço dela — e o que a Aliviar resolve
Quantas opiniões diferentes ela já ouviu	Confusão de informação é a dor central; nomeie-a depois
Se é para ela ou para outra pessoa	Muda quem decide e quem você vai acompanhar
O que ela diz que importa	"Quero alguém que me escute", "quero perto de casa", "quero quem opere pouco"

DEVOLVA ANTES DE SEGUIR

Antes de explicar qualquer coisa, **repita o que entendeu**: "Deixa eu ver se entendi: você está há [tempo] com [situação], já passou por [x] médicos, ouviu opiniões diferentes e não sabe em quem confiar. É isso?"

Este gesto faz mais pela venda do que qualquer argumento. É a primeira vez em muito tempo que alguém escutou a história inteira — e é *exatamente* o que a Aliviar entrega depois, em escala maior.

NÃO PEÇA EXAME, LAUDO NEM DIAGNÓSTICO POR ESCRITO AGORA

Nesta fase a Aliviar guarda só nome, contato e o que a pessoa contou. **Informação clínica é conversada com o Curador**, depois. Se ela oferecer, diga: "Guarda isso, que o Curador vai querer ver com calma."

3 · Explicar a Aliviar — em três frases, com o caso dela dentro

A EXPLICAÇÃO CURTA

"A Aliviar é uma **curadoria médica independente**. Um curador — que é médico — vai sentar com você, entender seu caso a fundo, e estudar os profissionais que atendem o que você precisa."

"No fim, ele te apresenta **três caminhos**, explicando por que cada um está ali, o que cada um oferece e **o que cada um custa em termos de tempo, deslocamento, jeito de trabalhar**. Aí você escolhe."

"A gente **não indica um**. A escolha é sua — a nossa parte é fazer você escolher sabendo."

Se ela citou algo específico, amarre ali: "*Você falou que queria alguém que explicasse com calma. Isso é uma das coisas que o curador avalia, e vai estar escrito no seu relatório.*"

As três frases que separam a Aliviar de tudo o que ela já tentou

- 1 **"Ninguém paga para aparecer aqui."** Nenhum médico paga para estar na nossa rede. Não existe patrocínio, não existe posição comprada. É a diferença entre nós e qualquer lista da internet.
- 2 **"Quem faz a curadoria é uma pessoa, não um algoritmo."** Um curador médico estuda seu caso e assina o que escreveu. Tem nome, e responde pelo que disse.
- 3 **"Você recebe explicação, não uma lista."** Não são três nomes num papel: é por que cada um, o que cada um oferece, e o que cada um custa.

4 · O preço — diga cedo, diga inteiro, sem rodeio

NÃO ESPERE ELA PERGUNTAR

Quem esconde preço até o fim ensina a pessoa a desconfiar. **Fale assim que terminar de explicar o serviço**, antes de qualquer pergunta. Você está numa posição confortável: é barato para o que entrega.

DIGA ASSIM

"Sobre valores, e eu prefiro falar agora: a Aliviar custa **R\$ 500 por um ano de contrato**. Isso cobre a curadoria inteira, o relatório com os três caminhos, e o **acompanhamento durante o ano todo** — alguém da nossa equipe com você para organizar documentos, marcar os próximos passos e responder quando você tiver dúvida."

"E pode ser parcelado: **12 vezes de R\$ 41,67, sem entrada** — a primeira na contratação."

"**A consulta com o médico que você escolher é à parte**, paga direto com ele — a Aliviar não recebe nada dessa consulta, e é justamente por isso que a gente pode ser honesta sobre quem apresentar."

OS NÚMEROS ESTÃO DEFINIDOS — E SÃO ESTES, SEMPRE (ADR-101 E ADR-107)

R\$ 500 pelo ano, em até 12× de R\$ 41,67, sem entrada. Não há outra combinação: você não tem margem para desconto nem para inventar um parcelamento diferente. **O que for dito na conversa vira compromisso.**

Se ela pedir mais prazo ou valor menor, a resposta é que o preço é o mesmo para todo mundo — *"não é que eu não queira, é que ele é igual para todas as pessoas, e é isso que me deixa poder ser honesto com você depois"*. Preço que cede para quem insiste cobra mais caro de quem não insistiu.

A FRASE QUE ANCORA O VALOR — USE SE ELA HESITAR NO PREÇO

"São **R\$ 500 pelo ano inteiro, ou R\$ 41,67 por mês**. Costuma ser menos do que uma consulta particular com especialista — e é para você não gastar três consultas até descobrir com quem devia ter ido desde o começo."

Diga uma vez. **Não repita e não insista**: quem argumenta duas vezes o mesmo preço está pedindo desculpa por ele.

5 · As objeções que vão vir — e o que responder

Ela diz	Você responde
"Por que eu não procuro sozinha?"	"Pode, e muita gente faz. A diferença é o que você tem para decidir. Sozinha, você compara pelo que está no site de cada um. Aqui, um médico estuda os três e te explica em que eles diferem <i>para o seu caso</i> . Você está pagando pelo estudo, não pelo nome."
"Isso é plano de saúde? Convênio?"	"Não. A Aliviar não é plano, não é seguro e não cobre consulta. É curadoria: a gente encontra e explica o caminho; o atendimento é com o médico."
"Vocês ganham comissão do médico?"	"Não, e é a coisa mais importante que eu vou te dizer hoje. Nenhum médico paga para estar aqui e a gente não recebe nada da consulta. Nosso único pagamento é o seu. É o que permite dizer 'esse aqui talvez não seja bom para você'."
"E se eu não gostar de nenhum dos três?"	"É um desfecho legítimo, e não é fracasso seu nem nosso. Você conversa com o curador, diz o que não serviu, e isso vira informação para a próxima rodada. Você não fica presa a três nomes."
"Quanto tempo demora?"	Não invente prazo. "Depende do seu caso e de quantos profissionais precisam ser avaliados. O curador te diz o prazo na primeira conversa, e a gente não some no meio."
"Vocês têm médico de [especialidade] em [cidade]?"	Não prometa cobertura que você não conferiu. "Deixa eu verificar com o curador antes de te responder — prefiro te dizer a verdade a te dizer o que você quer ouvir. Te retorno [prazo]."
"Preciso pensar."	"Claro. Posso te mandar por escrito o que a gente conversou, para você reler com calma? E te ligo [dia] para saber o que achou." Combine o retorno; não deixe em aberto.
"É para minha mãe / meu pai."	"Entendi. Então tem duas conversas: a sua, agora, e a dele. Quem decide no fim é quem vai ser cuidado — a gente monta a curadoria para ele, com você junto."

6 · O fechamento — combine o gesto seguinte, não peça um "sim"

Não pergunte "e aí, vamos fechar?". Ofereça o passo concreto, com data.

DIGA ASSIM

"O próximo passo é uma conversa com o curador, que é quem vai conduzir seu caso. Ele vai querer ouvir sua história com calma — dura mais ou menos [tempo]. **Quando fica melhor para você?**"

Marcado: "Combinado. Eu vou criar seu acesso ao sistema e te mando os dados por [canal]. Lá você acompanha tudo: as etapas, seus documentos e o relatório quando ficar pronto."

A SENHA APARECE UMA VEZ SÓ

Ao criar o acesso, o sistema mostra a senha **uma única vez**. Combine o canal de entrega *antes* de criar, anote no momento, e não improvise. Detalhes no **Guia do Supervisor**.

6b · As duas perguntas de viabilidade — antes de desligar

Com a conversa marcada, faltam duas perguntas curtas. Elas viram a dupla de **Viabilidade** da Ficha do Assistido — **Cobertura e convênio** e **Custo e pagamento** —, e o **Curador não vai repeti-las**: o médico que estuda o caso dela não conversa sobre dinheiro (ADR-108). Se você não perguntar, ninguém pergunta — e a Mesa cruza os 29 conceitos com dois em branco.

DIGA ASSIM

Cobertura e convênio: "Só mais duas coisas rápidas, para a Curadoria já sair certa: você tem plano de saúde? Se tiver, qual? E prefere usar o plano, reembolso, ou tanto faz se for particular?"

Custo e pagamento: "E pensando no tratamento em si — não na Aliviar —, existe algum limite de valor que a gente precisa respeitar na hora de escolher os caminhos? Pode ser 'não sei ainda', e pode ser 'prefiro não dizer'."

NÃO CONFUNDA OS DOIS PREÇOS

A pergunta do custo é sobre **o custo do tratamento que ela vai fazer** — não sobre o preço da Aliviar, que já está combinado e é fixo. Se ela achar que o valor voltou a estar em negociação, a conversa inteira volta para trás. Diga "não na Aliviar" em voz alta, como está no roteiro.

7 · O que você nunca promete

A REGRA, E O MOTIVO DELA

Tudo o que for dito nesta conversa vira expectativa, e a expectativa é cobrada na entrega. Um roteiro que promete a mais fecha a venda e **perde a pessoa depois** — junto com a confiança, que é o único produto que a Aliviar tem.

Nunca diga	Por quê
"O melhor médico da cidade"	A Aliviar não ordena por qualidade e não faz ranking. São três caminhos legítimos, sem preferência.
"A gente resolve seu problema de saúde"	A Aliviar organiza o caminho até o médico. O cuidado clínico é dele.
"Fica pronto em X dias"	Não existe prazo garantido. Quem dá prazo é o curador, com o caso na mão.
"A gente consegue encaixe / prioridade na agenda"	A Aliviar não controla a agenda de ninguém.
"É coberto pelo seu convênio"	Não temos como afirmar isso, e varia por plano e por médico.
Qualquer opinião clínica	Você não é o médico. "Isso é um caso de cirurgia?" se responde com "essa é exatamente a pergunta para o curador".

8 · Onde a sua VENDA termina — e por que ela termina ali

EMENDA DA ADR-100 (28/08)

A sua conversa não termina mais. Você deixou de ser recepção e passou a ser o **Supervisor do processo**: entrega o caso ao Curador, e continua ao lado da pessoa até o encerramento. O que termina neste ponto é a **venda**, não o acompanhamento.

Isso torna a fronteira abaixo **mais dura, não mais frouxa**. Antes, quem convenceu ia embora; agora quem convenceu *fica na sala*. Por isso, junto com a mudança de papel, duas regras — e elas viraram decisão própria na **ADR-101: o preço é fixo** — você não tem margem para desconto dentro da conversa — e **você não ganha por conversão**. Com as duas, você *comunica* um preço; não vende um.

Depois que o Curador assume, o seu papel muda de gênero junto com o dele: você acompanha, destrava e responde — **nunca opina sobre qual dos três caminhos**. Se a pessoa te perguntar qual é o melhor, a resposta é devolver a pergunta ao Curador. No minuto em que você tem preferência, é o produto inteiro que cai.

A FRONTEIRA QUE SUSTENTA O PRODUTO

A sua conversa é a única em que **convencer é legítimo**. Você está ajudando alguém a decidir se a Aliviar faz sentido — e isso é vender, no bom sentido: explicar até a pessoa entender.

A conversa do Curador é outro gênero, e não pode ser uma venda. Ele apresenta três caminhos sem preferência e sai da sala. No minuto em que o Curador empurra um dos três, a promessa que você fez — "ninguém paga para aparecer aqui", "a escolha é sua" — vira mentira, e o produto inteiro morre junto.

Por isso: **entusiasmo é seu, neutralidade é dele**. Não peça a ele que "ajude a convencer", e não prometa à pessoa que o curador vai dizer qual é o melhor. Ele não vai, e é isso que ela está comprando.

Antes do primeiro dia real

O que verificar	Por quê
A entrada e as parcelas estão preenchidas neste roteiro?	Estão em branco de propósito. Improvisar parcelamento na ligação cria compromisso que ninguém combinou.
Existe alguém com papel de Curador?	Você vai marcar a conversa dele na ligação. Sem Curador, você marcou algo que não existe.
Você sabe dizer, de cabeça, quais especialidades e cidades a Rede cobre hoje?	É a pergunta mais provável da ligação. Não saber é aceitável; inventar não é.
Como o contrato é assinado e como o pagamento é registrado?	O roteiro combina o começo; alguém precisa saber operacionalizar o que foi combinado.
A política de privacidade está publicada?	Hoje não está , por decisão registrada (ADR-096). A primeira Curadoria é com pessoa da equipe justamente por isso — este roteiro não deve ser usado com pessoa de fora antes da publicação.

Este roteiro descreve a oferta vigente em 28/08/2026 (ADR-107): R\$ 500 por um ano de contrato, em até 12× de R\$ 41,67 sem entrada, cobrindo a Curadoria, o Relatório e o acompanhamento do Concierge; consulta com o profissional paga à parte, direto com ele. Se a oferta mudar, este documento muda no mesmo dia — um roteiro com preço velho é pior que roteiro nenhum.

Nenhuma frase aqui promete o que o sistema não faz (ADR-064). Se alguma delas não bater com a realidade da operação, a operação está certa e este documento está velho — avise para ser corrigido.